



GUÍA DE
CUIDADOS PARA
PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN

Cuidamos
tu salud

Información
importante
para su
tratamiento
www.vithas.es

El propósito de esta guía es ayudarle a conocer de mejor modo qué es la hipertensión (HTA) y también darle algunos **consejos y recomendaciones** para reducir su tensión arterial (TA).

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE



ACERCA DE LA HIPERTENSIÓN

La hipertensión supone un problema de gran magnitud en los países desarrollados y en España afecta aproximadamente al **35% de la población adulta**. Según algunos estudios realizados, se demuestra que los pacientes tienen muchas dificultades para el cumplimiento del tratamiento médico. Se ha observado que el cumplimiento del tratamiento, junto con cambios en el estilo de vida, contribuyen a disminuir las cifras de presión arterial (PA) y el porcentaje de pacientes hipertensos.

Por tanto, el objetivo propuesto en la consulta de hipertensión, no sólo va a estar referido a conseguir unos valores normales de cifras de TA sino que, además, integra el

proceso mediante el cual el paciente conoce, acepta y asume que padece una enfermedad crónica que le acompañará toda su vida, y que los **beneficios** de seguir el régimen terapéutico superan al conjunto de problemas médicos y enfermedades que pueden desencadenarse si no lo hace, llegando incluso a la muerte.

En resumen, la HTA es una enfermedad grave y de carácter crónico, que puede controlarse llevando un estilo de vida saludable y/o con medicación, pero si no se controla puede llegar a disminuir la calidad de vida del paciente, ya que está muy relacionada con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que son **la primera causa de muerte** en los países occidentales.

¿QUÉ ES LA HIPERTENSIÓN?

Es una enfermedad producida por el aumento de presión de la sangre.

La presión depende de la fuerza con la que el corazón impulsa la sangre y la resistencia que oponen las arterias. Hablamos de hipertensión cuando las cifras de presión arterial (PA) o TA superan 140/90 mmHg (en diabéticos o pacientes de alto riesgo es 130/80 mmHg). La primera cifra es la **presión sistólica** (máxima) que es la fuerza con la que el corazón se contrae al impulsar la sangre, y la 2ª cifra (90 mmHg) es la **presión diastólica** (mínima) que es la presión con la que se dilata.

Existen dos tipos de hipertensión que conviene diferenciar, para dirigir de mejor modo el tratamiento más adecuado:

TIPOS DE HIPERTENSIÓN

Primaria o Esencial: la más frecuente, de origen desconocido y normalmente responde bien al tratamiento farmacológico y a la modificación de los estilos de vida.

Secundaria: se origina por una enfermedad, una sustancia o en algunos casos durante el embarazo. Normalmente cesa cuando desaparece la causa que la origina.

¿A CUÁNTAS PERSONAS AFECTA?

Afecta aproximadamente al 35 % de la población adulta española, pero el porcentaje se eleva hasta el **68 % en los mayores de 65 años** y se prevé que aumente en los próximos años.

En la tabla que vemos a continuación se describen las **cifras normales** y cuándo se considera hipertensión, teniendo en cuenta si hay más factores de riesgo asociados.

¿CUÁL ES LA TENSIÓN NORMAL?

<i>Categoría</i>	<i>Sistólica</i>		<i>Diastólica</i>
<i>Óptima</i>	<i><120</i>	<i>y</i>	<i><80</i>
<i>Normal</i>	<i>120-129</i>	<i>y/o</i>	<i>80-84</i>
<i>Normal alta</i>	<i>130/139</i>	<i>y/o</i>	<i>85-89</i>
<i>HTA grado I</i>	<i>140-159</i>	<i>y/o</i>	<i>90-99</i>
<i>HTA grado II</i>	<i>160-179</i>	<i>y/o</i>	<i>100-109</i>
<i>HTA grado III</i>	<i>>180</i>	<i>y/o</i>	<i>≥110</i>
<i>HTA sistólica aislada</i>	<i>>140</i>	<i>y</i>	<i><90</i>
<i>Diabéticos</i>	<i>>120</i>	<i>y/o</i>	<i>≥75</i>

¿QUÉ SÍNTOMAS PUEDE DAR LA HTA?



- ✓ Puede que no tenga síntomas y tenga la TA alta, con lo cual es muy importante una **revisión médica** periódica.
- ✓ Pueden aparecer síntomas como mareos, vértigos, irritabilidad, disminución de memoria, zumbido de oídos, visión de lucecitas, dolor de cabeza en zona occipital, etc.
- ✓ En otras ocasiones las manifestaciones clínicas se deben a una complicación por **afectación** de algún órgano:
 - *Corazón*: Infarto Agudo de Miocardio o Insuficiencia Cardíaca.
 - *Riñón*: Insuficiencia renal.
 - *Cerebro*: ictus tanto isquémico como hemorrágico.
 - *Ojos*: retinopatía.

¿QUIÉN DEBE TOMAR LA PRESIÓN ARTERIAL?

Sólo puede hacerlo el personal de salud capacitado, preferiblemente el Médico de Familia.

¿CUÁNDO CONSIDERAMOS QUE UN PACIENTE ES HIPERTENSO?

Consideramos que una persona de 18 años de edad o más es HIPERTENSA si en tres ocasiones distintas ha tenido cifras de 140/90 o más de PA. Para ello se realizan tres mediciones de su tensión arterial en tres ocasiones diferentes (o más) en un espacio de tiempo de entre tres y siete días.

FACTORES DE RIESGO PARA APARICIÓN DE LA ENFERMEDAD

- ✓ Herencia: antecedentes familiares.
- ✓ Edad mayor de 60 años, sexo, raza.
- ✓ Enfermedades asociadas como Diabetes Mellitus.
- ✓ Otros: hábito tabáquico.
- ✓ Ambientales:
 - Ingesta excesiva de alcohol.
 - Ingesta excesiva de sal.
 - Ingesta excesiva de grasa animal.
 - Falta de ejercicio (sedentarismo).
 - Exceso de peso corporal.
 - Aumento de cifras de colesterol sanguíneo.



ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS

Cambios en el estilo de vida

Conviene destacar que los cambios en el estilo de vida pueden retrasar la aparición de la enfermedad en pacientes no hipertensos, retrasando o previniendo el tratamiento farmacológico en

HTA grado I, y **ayudar a reducir las cifras de PA** en pacientes en tratamiento farmacológico, así como disminuir el número dosis de fármacos a emplear.

A continuación se detallan las siguientes medidas:

- ✓ Restricción del consumo de **sal en la dieta**: entre 5 y 6 g es la cantidad diaria recomendada de sal.
- ✓ Se deben evitar los **alimentos ricos en sal** (carnes procesadas, conservas, frutos secos salados, ciertos cereales, quesos, galletas saladas, snacks...etc).
- ✓ Moderación en el consumo de alcohol: un **excesivo consumo de alcohol** se asocia a un aumento de cifras de PA y de ictus.
- ✓ Otros cambios en la dieta: deberán **aumentar el consumo** de hortalizas, productos lácteos desnatados, fibra dietética y soluble, cereales integrales y proteínas de origen vegetal con menos grasas saturadas y colesterol. La fruta fresca también es recomendable pero con precaución en pacientes diabéticos, porque pueden tener alto contenido en hidratos de carbono.
- ✓ Los ajustes de la dieta deben ir acompañados de otros cambios en el estilo de vida. La dieta que comentamos -también llamada Dieta DASH- acompañada de **pérdida de peso y ejercicio** consiguen una mayor reducción de la PA que si solo realizamos dieta.

- ✓ Reducción de peso: excepto cuando esté contraindicado, está recomendado reducir el **peso corporal a IMC = 25**; circunferencia abdominal (cintura) a 102 cm para hombres y 88 cm para mujeres.
 - ✓ Realizar **ejercicio físico** de forma regular: al menos 30 minutos de ejercicio dinámico moderado (caminar, correr o montar en bicicleta) entre cinco a siete días a la semana.
- Se aconseja a todos los fumadores que **abandonen el hábito tabáquico** y que soliciten asistencia.

Tratamiento farmacológico

De entre todas las alternativas terapéuticas disponibles, el médico elegirá la que mejor se adapte al paciente según **protocolos de actuación**, teniendo en cuenta las características de cada uno, patología de base..., etc.

Las circunstancias que se describen a continuación requieren una vigilancia y control de las cifras de TA más estrecho, por parte del médico:

SITUACIONES ESPECIALES

HTA de la bata blanca

Se manifiesta cuando la presión del paciente se eleva **en la consulta** del médico pero al salir del centro sanitario se reduce, hasta normalizarse. En estas situaciones, y si no hay factores de riesgo adicionales, se recomienda un cambio de estilo de vida junto con vigilancia estrecha por parte de su médico.

HTA enmascarada

Se define por cifras de PA normales en la consulta del médico y cifras elevadas **fuera de la consulta**. Precisa para su diagnóstico de una medición ambulatoria mediante el denominado MAPA (un monitor conectado a un manguito que usted lleva en su brazo, donde

se registran las mediciones de PA cada intervalo de tiempo determinado mientras usted desarrolla su actividad diaria, durante unas 24h; y que posteriormente su médico leerá)

HTA en el paciente anciano

Los pacientes ancianos son especialmente sensibles a los cambios en cifras de PA, por lo que se requerirá una vigilancia y control médico más estrechos, sobre todo si están bajo tratamiento.

HTA en mujeres

Las pacientes que están sometidas a tratamiento con anticonceptivos orales, menopausia con terapia hormonal sustitutiva o las embarazadas tienen mayor riesgo para presentar hipertensión, por lo que requieren vigilancia de sus cifras de PA.

Existencia de síndrome metabólico

Es decir, pacientes con otros factores de riesgo cardiovascular como diabetes, obesidad..., etc., en los que se exige un control más estrecho.

En los pacientes diabéticos

En aquellos que presenten afectación en órganos 'diana', que son los que reaccionan ante un estímulo en particular, como el corazón, los riñones, el cerebro o la retina. Son casos donde las cifras de PA deben estar por debajo de 120/70, puesto que cifras más altas contribuyen al empeoramiento de la enfermedad preexistente.

¿CÓMO SE HACE EL SEGUIMIENTO?

Una vez que su médico ha instaurado tratamiento y explicado la estrategia a seguir, le revisará a intervalos de **2-4 semanas** para controlar los posibles efectos secundarios de los fármacos y si está siendo eficaz.

Los pacientes con HTA de bata blanca deben ser revisados al menos una vez al año y valorar los factores de riesgo cardiovasculares asociados.

Si en la consulta de control se detectan **cifras de presión elevadas** su médico investigará las causas de la misma: no cumplimiento terapéutico, consumo de sal, ingesta de alcohol o toma de antiinflamatorios...

Si se considera que el tratamiento es ineficaz, su médico puede plantear el aumento de la dosis del fármaco, añadir más fármacos o cambiar la dosificación de los mismos, citándole de nuevo en **2-4 semanas**, para una revisión.

Su médico solicitará con **periodicidad anual** (al menos) una analítica con medición de urea y creatinina (función renal), iones, radiografía de tórax y electrocardiograma (para ver si hay afectación del corazón).

¿SE PUEDE REDUCIR O INTERRUPIR EL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO?

En algunas ocasiones en que el tratamiento se acompaña de control eficaz de la PA durante algún tiempo largo, su médico **puede decidir la reducción** del número y dosis de fármacos, sobre



todo si se acompaña de cambios en el estilo de vida como pérdida de peso, dieta baja en grasas, ejercicio físico regular. La reducción de la medicación debe realizarse gradualmente para evitar la reaparición de HTA.

Más información en:
Sociedad Española
de la Hipertensión
<https://goo.gl/u1a3c3>



Autores: Dra. Sonia Suárez

Coordinadora médica Hospital Vithas
Virgen del Mar Almería

Dr. Ricardo Fajardo Molina

Cardiólogo Hospital Vithas Virgen del Mar Almería

GUÍA DE
CUIDADOS PARA
PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN

Cuidamos
tu salud

Información
importante
para su
tratamiento
www.vithas.es